

신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**
- 강조: **빨간색 밑줄**
- 말없이 지나간 부분: 회색

[1] 물질관련 및 중독 장애

1절. 개요

물질(Substance)이란?

- 섭취하는 물질 중 중독성을 지니고 있어 몸과 마음에 부정적인 영향을 미치는 것들
- 뇌에 영향을 주어 의식이나 마음을 변화시키는 물질
- 뇌를 변화시키는 물질로서 과량 복용할 때 행동과 기억 생성을 강화하는 뇌 보상 체계를 활성화하고 정상적인 뇌 활성화신호들을 무시하게 한다.
- 의존성이 생겨 중독상태가 되면 개인의 심리적 기능이 손상, 사회 활동이 어려워지며 재정적 곤란, 가정의 파탄, 심리적 황폐화를 초래하여 폐인상태로 전락하기도 한다.
- 대표적 물질: 알코올, 마약



용어 정의

Substance abuse (물질 남용)	뇌에 영향을 주어 의학상태 또는 심리상태를 변화시킬 수 있는 물질을 의학적 사용과는 상관없이 지속적 사용 으로 인해, 사회적 또는 직업상 기능장애가 나타나게 되는 상태. 내성, 금단, 강박적 사용 없음.
Dependence (물질 의존)	물질 남용보다 심각한 상태 물질을 복용하려는 강한 열망, 사용을 통제하는데 어려움. 해로운 결과에도 불구하고 사용을 절제하지 못함.

	심리적, 신체적 의존. 내성, 금단증상, 강박적 사용이라는 3가지 뚜렷한 특징
Tolerance (내성)	심적, 신체적으로 만족할만한 효과를 얻기 위해 양을 늘리는 경우
Addiction (중독)	물질에 대해 반복적으로 사용하여 자주 중독상태에 있고, 탐닉하여 중단하지 못하는 행동
Intoxification (중독)	addiction과 다르게 물질에 취해있는 상태. 특정 물질에 의한 가역적 증후군
Acute intoxication (급성 중독)	신체에 흡수된 물질에 의해 직접적으로 효과가 나타난 상태
Withdrawal (금단)	갑자기 물질을 중단하거나 줄였을 때 나타나는 신체적, 심리적 자율신경계 증상. 약물 다시 사용하면 사라짐

헛갈리는 용어들

① 남용 VS 오용 VS 해로운 사용

- **남용(abuse)**: 약물의 비의학적 사용, 감정이나 행동을 흥분시키기 위한 목적으로 약물을 사용하는 것 Ex) 청소년들이 술과 담배, 본드 등을 무분별하게 이용하는 것
- **오용(misuse)**: 처방된 약을 지시대로 사용하지 않는 경우, 약을 본래의 목적에 맞지 않게 잘못 사용하는 것 Ex) 다이어트를 위해서 버비약이나 이뇨제를 사용하는 것
- **해로운 사용(harmful use)**: 신체, 정신적 장애를 일으킬 정도의 과도한 약물복용 양상. ICD-10에서는 DSM의 abuse 남용과 유사한 의미

② Intoxication VS Addiction – 둘 다 중독

- **Intoxication**: 생체가 음식이나 약물의 독성에 의해 보이는 기능장애. **취한 상태**
- **Addiction**: 술, 마약 따위 없이 견디지 못하는 상태. **의존**과 비슷한 통합적 개념

③ 신체적 의존 VS 심리적 의존 – 둘 다 의존(dependence)

- **신체적 의존**: 약물 사용으로 생리상태가 변하여 내성 및 금단이 나타나는 상태
- **심리적의존**: 약물의 계속적 사용으로 긴장감이나 감정적 불편을 해소함

④ 교차 내성 VS 저항성 - 둘 다 내성(tolerance)과 비슷

- **교차 내성(cross tolerance)**: 내성이 생긴 약물에 대해 비슷한 구조를 가진 다른 약물에 도 내성
- **항생제 저항성(resistance)**: 돌연변이로 인해 약에 대한 반응이 감소

Rice의 약물중독 진행단계

실험적 사용단계	처음에 호기심 또는 모험심에서 약물을 단기간, 적은 양 사용하는 것에서 시작
사회도구적 사용단계	또래 집단에서 즐거움을 공유하고 집단 구성원이 되기 위한 동기로 사용
상황적 사용단계	특정 상황에서 정서적, 정신적 자극의 필요에 따라 사용
심화적 사용단계	더 나아가 일상 문제와 스트레스를 벗어나기 위해 장기간 남용
강박적 사용단계	최종적으로 약물의 효과 또는 심리상태를 유지하기 위해 다량의 약물을 자주, 장기간 사용. 약이 있어야 정상 상태를 유지

중독(Addiction)의 4C

- 중독의 진단에 있어 약물 사용의 양, 빈도보다 4C의 유무가 더 중요하다.

① Control(통제): 조절이 안되는 것

- 의도한 것보다 더 많은 물질을 사용
- 오랜 기간 사용

② Compulsions(강박)

- 사용에 대한 생각, 사용 계획, 사용 숨기기 등 정신적 공간 전체

③ Carvings(갈망)

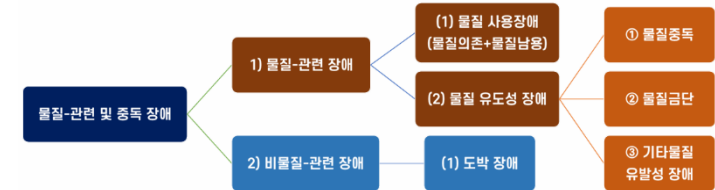
- 물질을 사용하고 싶다는 거슬리는 생각, 매우 압도적
- 강렬한 욕구가 신체적으로 표현될 수 있다.(금단증상도 일종의 갈망의 신체적 표현일 수 있음)

④ Consequences(결과): 결과를 알면서도 사용하는 것

- 물질 사용으로 초래되는 결과에도 불구하고 계속 사용
- 여기서 결과는 신체적 건강 뿐 아니라 관계적, 직업적, 도덕적 결과 등 모두 포괄

2절. 물질관련 및 중독장애(DSM-5)

- 물질관련 및 중독장애: 술, 담배, 마약과 같은 중독성 물질을 사용하거나 중독성 행위에 몰두함으로써 생겨나는 다양한 부적응적 증상을 포함하고 있음



1. 물질-관련장애(Substance-related disorder): DSM-4까지는 의존과 남용을 구분했지만 DSM-5는 구분X

(1) **물질 사용장애**: 특정한 물질을 **과도하게 사용함**으로 인해 개인적 고통과 사회적 부적응이 초래되는 경우를 말함. (남용+의존)

(2) **물질유도성장애**: 특정한 물질을 **섭취했을 때 나타나는 부적응적인 심리상태**를 뜻함.

- **물질 중독**: 특정한 물질의 과도한 복용으로 인해 일시적으로 나타나는 부적응적인 증상군
- **물질 금단**: 지속적으로 사용하던 물질을 중단했을 때, 발생하는 신체생리적, 심리적 증상군
- **물질유도성 정신장애**: 물질 남용으로 인해 일시적인 심각한 중추신경장애

- 10가지 유목: 알코올, 담배, 카페인, 대마, 환각제, 흡입제, 아편제, 진정수면제 또는 항불안제, 흥분제, 기타물질(스테로이드, 코르티솔 등)

- 물질별로 구체적인 진단이 가능 Ex) 알코올사용장애, 담배사용장애를 각각 내릴 수 있음
- 카페인도 물질 사용장애, 담배는 담배 중독, 환각제와 흡입제는 물질 금단에 대한 내용이 없다.

- 물질관련장애는 감별진단에 대한 항목이 따로 없다. 다른 정신장애와 함께 진단한다.

- Substance Use Disorders (물질사용장애)
 - Dependence 의존 / Abuse 남용
- Substance-Induced Disorders (물질로 유발된 장애)
 - Intoxication 중독 / Withdrawal 금단
 - Intoxication Delirium
 - Withdrawal Delirium
 - Substance-Induced Persisting Dementia
 - Substance-Induced Persisting Amnesic Disorder
 - Substance-Induced Psychotic Disorder
 - Substance-Induced Mood Disorder
 - Substance-Induced Anxiety Disorder
 - Substance-Induced Sexual Dysfunction
 - Substance-Induced Sleep Disorder
 - Substance-Related Disorder NOS

2. 비물질-관련장애(Non-substance-related disorders)

- (1) 도박장애: 노름이나 도박을 하고 싶은 강렬한 충동 때문에 반복적인 도박행위를 하게 되는 경우 도박행위를 12개월 이상 지속하여 심각한 부적응이나 개인적 고통을 초래한 경우에 도박장애로 진단.
- (2) (+a) 게임중독: 고려해야 할 의학적 상태로 보고 있다.

3절. 물질사용장애(Substance use disorders)

- DSM-4에서는 남용과 의존을 구분했지만 DSM-5에서는 구분하지 않는다.

DSM-5의 물질사용장애 진단기준

1년동안 다음 중 2가지 이상의 기능장애나 고통을 유발하는 부적응적인 물질사용

조절능력의 손상	1. 의도보다 많이 투여 2. 끊으려 하나 실패 3. 물질을 얻기 위한 시간/노력 소모 4. 갈망
사회적 손상	5. 학업/직장생활/가사에 지장(결석/결근, 해고, 자녀방치 등) 6. 사회/대인관계의 지장이 있음을 알면서도 사용 7. 사회/직업/취미생활의 포기 또는 감소
위험한 물질사용	8. 위험한 상황에서의 물질 사용(운전, 기계조작 등) 9. 신체적/정신적으로 해롭다는 것을 알면서도 사용
약물학적 진단기준	10. 내성(같은 효과를 내기 위해 점점 많은 물질이 필요/같은 양의 물질의 효과가 점차 감소) 11. 금단(해당물질의 특징적 금단증상, 또는 금단증상을 피하기 위해 물질 사용)
- 경도(mild): 2~3개 / 중등도(moderate): 4~5개 / 중증도(severe): 6개 이상	

- 내성과 금단이 필수 진단조건이 아니다. But 내성, 금단이 있으면 예후가 더 안 좋다.

갈망(Craving)

- 갈망(craving): 무엇인가에 대한 강력한 욕망 (a powerful desire for something)
- 물질사용장애의 악화, 재발 등을 발생시키는 주요 요인
- 과거 금단증상 중 하나로 간주 → DSM-5에서 물질사용장애 진단기준의 하나로 포함
 - 금단증상이 사라진 후에도 오랜 기간 갈망을 경험하는 것을 관찰되면서 진단기준의 하나로 포함시킴
- 중독의 영역: 물질사용에 대한 욕구(좁은 의미), 물질사용에 대한 충동(넓은 의미)
- 금단 중의 술에 대한 갈망은 '신체적 의존(physical dependence)', 단주 기간 동안 알코올에 대한 갈망은 '병적 욕망(pathological desire)'
- 갈망의 생물학적 분류
 - 보상갈망(reward craving): 도파민, 오피오이드 시스템. 쾌락. 가족력, 날트렉손
 - 해소갈망(relief craving): GABA시스템 관련. 스트레스 감소. 아캄프로세이트
 - 강박갈망(obsessive craving): 세로토닌 감소로 인한 정동의 불안정성. 장기간 금주 후 우연히 마셨을 때 유발되는 부분
- 갈망의 생물학적 측면: 물질에 대한 보상회로
 - 도파민 시스템: 뇌의 보상체계에서 알코올 섭취와 갈망의 기전에 중요한 역할
 - 세로토닌: 오피오이드 수용체의 간접적인 활성화. 이전의 자극은 시상하부의 세로토닌 방출을 결정
- 치료적 접근: 중독의 자동처리과정 → 비자동처리과정(중독물질을 사용했을 때 자동으로 얻게 되는 것을 못 얻게 만드는 것)
 - 항갈망제
 - (1) 날트렉손: 오피오이드 수용체 항길항제, 알코올의 보상효과 감소. 술 먹고 좋은 느낌을 안 들게 함
 - (2) 아캄프로세이트: NMDA수용체 길항제, 알코올 금단시 발생하는 부정적 증상 감소 술 끊어도 괜찮게 해줌
 - 심리적 접근
 - (1) 주의분산: 갈망이 생길 때 외부대상으로 주의를 돌리는 것
 - (2) 심상법: 중독이 계속되었을 때 얼마나 나빠질지, 끊으면 가족들이 얼마나 좋아할지 상상하는 것
 - (3) 자극조절법: 외부의 유발되는 충동들을 최대한 피하기
 - (4) 갈망이 발생할 상황 피하기, 갈망의 강도와 지속시간을 줄이기

• 전기자극

- (1) rTMS(경두개자기자극술): 코일에서 발생하는 자기장으로 특정부위의 신경세포의 활성을 낮추는 자극술
- (2) tDCS(경두개 직류전기자극술): 뇌표면에 직류자극을 보내 자발적인 활성을 일으켜 뇌기능을 정상화하고 증상을 완화시키는 방법
- (3) tVNS(경피적 미주신경자극술): 중추신경과 연결된 미주신경을 비침습적인 방법으로 자극해서 자율신경, 뇌신경의 활성화를 돕는 것. 이침을 활용해 볼 수 있음

4절. 물질유도성 장애(Substance-induced disorder)

물질 중독(Substance intoxication)

- A. 최근물질 섭취로 인해 가역적인 물질 특이 증후군이 발생함. (필수적 특징)
- B. 심각한 문제적 행동변화 및 심리적 변화(예: 공격성, 기분가변성, 판단력 손상)는 물질이 중추신경계에 작용한 생리적 효과로 인한 것이고, 물질 사용하는 동안 혹은 사용 직후에 발생함.
- D. 다른 의학적 상태로 인한 것이 아니고, 다른 정신질환으로 더 잘 설명되지 않음.
- 물질중독은 물질사용장애에서 흔하지만, 물질사용장애가 없는 사람에게도 종종 발생할 수 있음.
 - 담배에는 적용되지 않음
 - 단기간 중독(급성 중독), 지속성 중독(만성 중독)
 - 코카인: 사교적인 상태 vs 사회적 위축
 - 중독은 때로는 물질이 몸에서 검출되지 않는 상태에서 지속되기도 함
 - 중추신경계가 물질의 영향으로부터 회복되는 것이 물질을 제거하는 것보다 오랜 시간이 필요하기 때문이다.

물질 금단(Substance Withdrawal)

- A.과도하게 장기간 사용해 온 물질의 사용 중단 혹은 감량으로 인해 생리적 인지적 장애와 더불어 물질 특유의 부적응 행동 변화가 발생하는 것. (필수적 특징)
- C. 사회적, 직업적, 또는 다른 중요한 기능 영역에서 임상적으로 현저한 고통이나 손상 초래함.
- 대부분 보통 물질사용장애와 관련이 있음.

물질/치료약물로 유발된 정신질환(Substance/medication-Induced Mental Disorders)

- 남용물질, 치료약물 또는 몇몇 독소로 인해 발생하는 잠재적으로 심하고, 주로는 일시적이지만, 때로 지속하기도 하는 중추신경계 증후군임.
- 물질로 유발된 정신질환은 물질 중독이나 물질남용으로 인한 금단으로 발생함.
- 주로 일시적이고 급성 금단, 심한 중독, 치료약물 사용 후 1개월 이내에 사라지는 편임.
 - 예외: 알코올로 유발된 신경인지장애, 흡입제로 유발된 신경인지장애, 진정제, 수면제 또는 항불안제로 유발된 신경인지장애, 환각제 지속성 지각장애 → 후유증을 남김
- 증상의 심각도와 상관없이 사용을 중단하면 즉각 회복되는 편임.
- 우울, 불안, 망상장애 등이 물질 때문에 발생되었다고 판단되면 그냥 정신장애로 진단하는 것이 아닌 물질로 유발된 정신장애로 진단한다.

DSM-5의 '물질/치료약물로 유발된 정신질환' 진단기준

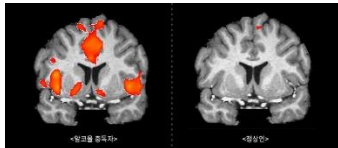
A. 장애는 관련된 정신질환의 증상적인 표현이 임상적으로 현저하게 나타남
B. 병력, 신체 검진 또는 검사 소견에서 다음의 2가지 증거가 있음
1)장애는 물질 중독 상태 혹은 금단 상태 혹은 치료약물을 복용한 상태에서 발생, 혹은 그로부터 1개월 이내에 발생하고
2)관련된 물질/치료약물은 정신질환을 일으킬 수 있음
C. 장애는 독립적인 정신질환으로 더 잘 설명되지 않음
1)심한 중독 상태 혹은 금단 상태 혹은 치료약물에 노출되는 시기보다 장애 발생 선행
2)심한 중독 상태 혹은 금단 상태 혹은 치료약물을 복용한 상태가 지나고 상당 기간 동안(최소한 1개월 이상) 완전한 정신질환이 지속됨
D. 장애는 섬망의 경과 중에만 발생하지 않음
E. 장애는 사회적, 직업적 또는 다른 중요한 기능 영역에서 임상적으로 현저한 고통이나 손상을 초래함.

- 진정작용이 있는 약물(진정제, 수면제, 항불안제, 알코올): 중독상태에서 현저하고 임상적으로 심각한 우울장애를 유발할 수 있고 + 금단상태에서는 불안상태가 관찰됨
- 흥분작용이 있는 약물(암페타민, 코카인): 중독상태에서 물질로 유발된 정신병적 장애, 물질로 유발된 불안장애가 동반되기 쉽고 + 금단상태에서 물질로 유발된 주요 우울삽화가 동반되기 쉬움.

[2] 알코올 관련 장애(Alcohol-Related Disorders)

1절. 개요

- 매년 전 세계적으로 300만명 이상이 음주로 사망, 우리나라에서도 매일 13명이 사망
- 알코올 사용장애의 평생 유병률 11.6%
 - 남성: 17.6% / 여성: 5.4% → 남녀 비율 5:1이나 연령, 문화권, 계층에 따라 다양
 - 여성은 남성에 비해 인생의 후반기에 과도한 음주를 시작, 발생하면 매우 급속도로 진행
- 술은 범죄로도 이어져서 자신은 물론 타인의 행복과 생명을 위험에 빠뜨림.
 - 전체 교통사고 사망 50%가 음주운전 / 타살의 40%, 자살의 25%가 알코올중독 관련
 - 살인, 강간, 폭력 등의 강력범죄 중 30~40%는 음주상태에서 발생
- 우울장애, 불안장애, 조현병 등 다른 정신장애 동반
- 알코올: 1급 발암물질, 뇌세포 파괴
- 알코올 중독: 술을 조절할 수 있는 능력이 없는 사람들
- "음주 충동이 가라앉지 않고, 술이 들어가기 시작하면 더 강하게 지속되어 술이 술을 먹 더라."
- 술을 못 먹게하는 반응들(브레이크)이 제대로 나타나지 않음 → 유전성
 - 술을 처음 먹으면 속도 안 좋고 잠도 오고 여러 반응이 나타나는데 어느정도 술이 들 어오면 몸에서 술을 못 먹게 하는 자연스러운 방어체계가 작동하는 것이다.
 - 알코올 의존자의 아들이 알코올 의존자가 되는 비율 25% (일반인 4배)
 - 알코올 의존자의 가까운 친척 중 80%이상이 관련 문제 지님.
- 가족, 또래집단, 관용적인 문화 등 사회문화적 요인



술 사진을 보여주면 알코올 중독자는 뇌가 활성화된다. 환자는 정작 별생각 없다고 말할 수도 있지만 무의식적으로 술을 먹도록 뇌가 작용하는 중이다. → 알코올 중독은 단순한 의지력 문제가 아닌 뇌질환의 일종이다.

알코올 소비

적당한 음주(알코올 문제의 위험이 낮음)	
여성 연령 <65	하루에 1잔 이하, 일주일에 7잔 미만
남성 연령 <65	하루에 2잔 이하, 일주일에 14잔 미만
65세 이상인 사람	하루에 1잔 이하, 일주일에 7잔 미만
과음(알코올 문제의 위험이 있음)	
여성	하루에 3잔 이상 또는 일주일에 7잔 이상
남성	하루에 4잔 이상 또는 일주일에 14잔 이상
폭음	
여성	1회 음주 시 ≥4잔 이상
남성	1회 음주 시 ≥5잔 이상

- 진단에서 중요한 것은 사용량, 빈도가 아닌 4C이긴 하지만 많이 마실수록 진단기준을 충족할 가능성이 높아지니 소비량을 확인하는 것은 중요하다.

DSM-5에서 알코올 관련 장애의 분류

DSM-IV-TR ALCOHOL-RELATED DISORDERS	DSM-5 Alcohol-Related Disorders
Alcohol Use Disorders	Alcohol Use Disorder
Alcohol Dependence	Alcohol Intoxication
Alcohol Abuse	Alcohol Withdrawal
Alcohol-Induced Disorders	Other Alcohol-Induced Disorders
Alcohol Intoxication	Unspecified Alcohol-Related Disorder
Alcohol Withdrawal	
Alcohol Intoxication Delirium	
Alcohol Withdrawal Delirium	
Alcohol-Induced Persisting Dementia	
Alcohol-Induced Persisting Amnestic Disorder	
Alcohol-Induced Psychotic Disorder	
Alcohol-Induced Mood Disorder	
Alcohol-Induced Anxiety Disorder	
Alcohol-Induced Sexual Dysfunction	
Alcohol-Induced Sleep Disorder	
Alcohol-Related Disorder NOS	

2절. 알코올 사용장애(Alcohol use disorder)

- 과도한 알코올 사용으로 인해 발생하는 부적응적 문제들
- 진행단계

전알코올성 단계	사교적 목적으로 음주. 술에 대한 긍정적 효과
전조단계	술에 대한 매력이 증가하는 시기. 술을 이용하여 기분의 변화를 느끼려 함. 음주횟수 증가, 기억상실
결정적 단계	음주가 습관. 행동 통제가 서서히 상실되는 단계. 수시로 술을 마시고, 혼자 마시기도 하며, 식사를 거르면서 술을 마신다. 비참한 변화를 극복하기 위해 술을 더 마심
만성단계	술에 대한 통제력이 완전히 상실. 술을 마시기 위해 사는 사람처럼 보인다

- DSM-5의 '알코올 사용장애' 진단기준(알의 물질사용장애 진단기준과 동일)

A.손상 및 고통을 일으키는 알코올 사용 양상이 지난 **12개월** 사이에 다음의 항목 중 **2개** 이상

- ① 알코올을 종종 의도했던 것보다 많은 양, 혹은 오랜 기간 사용
- ② 알코올 사용을 줄이거나 조절하려는 욕구 존재 or 노력했지만 실패한 경험 있음
- ③ 알코올을 구하거나, 사용하거나, 그 효과에서 벗어나기 위한 활동에 많은 시간 보냄
- ④ 알코올에 대한 갈망감, 강한 욕구
- ⑤ 반복적인 알코올 사용으로 직장, 학교, 가정에서의 주요한 역할 책임 수행 실패
- ⑥ 알코올의 영향으로 사회적(대인관계) 문제 발생 및 악화됨에도 알코올 사용 지속
- ⑦ 알코올 사용으로 인해 중요한 사회적, 직업적 혹은 여가 활동을 포기 및 줄임
- ⑧ 신체적으로 해가 되는 상황에서도 반복적으로 알코올 사용
- ⑨ 사용으로 인해 신체, 심리적 문제가 생기거나 악화될 수 있음을 알면서 알코올 사용

⑩ 내성
(둘 중 하나)
a. 중독 or 원하는 효과를 얻기 위해 알코올 사용량의 뚜렷한 증가가 필요
b. 동일한 용량의 알코올을 계속 사용할 경우 효과가 현저히 감소

⑪ 금단
(둘 중 하나)
a. 알코올의 특징적인 금단 증후군 (알코올 금단의 진단기준 A, B 참고)
b. 금단 증상을 완화하거나 피하기 위해 알코올(or 벤조디아제핀)을 사용

- 경도: 2~3개 / 중등도: 4~5개 / 중증도: 6개 이상

3절. 알코올 중독(Alcohol intoxication)

- 경도 알코올 중독의 증거는 대부분 개인에게서 대략 2잔의 술을 마신 후 관찰됨
- 혈중 알코올 농도가 올라가게 되면 어눌한 언어, 몸을 못 가누게 되고, 불안정한 보행, 집중력 또는 기억력의 손상과 더불어 심한 경우 정신적 혼미 또는 혼수상태
- 복용량에 따른 증후
 - 음주 초반: 혈중 알코올 농도가 높아지면서 말이 많아지고, 안정감, 쾌활한 팽창 기분이 나타남.
 - 음주 후반: 혈중 농도가 떨어지면서 더 우울해지고, 위축되며, 인지손상이 생김.
 - 매우 높은 혈중 알코올 농도(200~300mg/dL): 잠이 들고, 마취의 첫번째 단계에 들.
 - 더 높은 혈중 알코올 농도(300~400mg/dL): 호흡과 맥박이 저하되고, 심지어 사망할수 있음

DSM-5의 '알코올 중독' 진단기준

- A.최근의 알코올 섭취가 있음
- B.알코올을 섭취하는 동안 또는 그 직후에 임상적으로 심각한 문제적 행동변화 및 심리적 변화가 발생함 (예: 부적절한 성적 또는 공격적 행동, 기분 가변성, 판단력 손상)
- C.알코올을 사용하는 동안 또는 그 직후에 다음 징후 혹은 증상 중 한가지(혹은 그 이상)가 나타남.
- 1)불분명한 언어
 - 2)운동실조
 - 3)불안정한 보행
 - 4)안구진탕
 - 5)집중력 또는 기억력 손상
 - 6)혼미 또는 혼수
- D.징후 및 증상은 다른 의학적 상태로 인한 것이 아니며, 다른 물질 중독을 포함한 다른 정신질환으로 더 잘 설명되지 않음.

알코올의 효과

- 알코올: 10%는 위에서, 나머지는 소장에서 흡수.
- 알코올 농도 절정에 이르는 시기는 흡수된지 40~60분 후
- 음주량의 10%는 폐와 신장, 90%는 산화를 통해 대사
- 간에서 시간당 10~34mg/dl 대사. 아세트알데히드로 대사됨 이게 숙취의 원인
- 알코올은 소장에서 비타민 흡수를 방해. 간에서 비타민 저장을 감소.
- 엽산, B6, **B1(티아민)**, niacin B3, vit A에도 영향
- 과음 → 식사부족으로 인해 포타슘, 마그네슘, 칼슘, 아연, 인 결핍
- 음주나 금단 시 산-염기 불균형, 6~36시간 사이 일시적 저혈당
- 여성은 알코올 서서히 대사하므로 더 위험. 높은 혈중 알코올농도(남녀의 진단기준 차이 의 원인)



알코올중독이 중추신경계에 미치는 영향

기억상실	음주자의 35%, 일시적 선행기억 상실
수면변화	수면단계의 변화, 깊은 수면의 부족, 꿈 수면약화로 수면후기에 수면을 방해하는 꿈, 인두의 근육을 이완시켜 코를 골게 하거나, 수면무호흡 악화 잠은 잘 오지만 수면의 질을 떨어뜨림
판단력, 균형, 운동협응능력	손상으로 사고를 유발하며 그 빈도나 정도가 심하고, 사고의 절반에서 물질과 관련
말초신경병증	티아민결핍, 5~15%, 치료는 금주와 티아민 공급
베르니케 증후군	급성적 뇌병증, 티아민 결핍 관련, 섬망, 안마비, 조화운동불능, 뇌병증
코르사코프 증후군	알코올로 유발된 지속적 기억상실장애, 유전적 트랜스케토레이즈

	결핍과 관련(베르니케 증후군이 진행된 것)
소뇌퇴행	알코올 중독자의 1%에서 나타남. 점점 불안정해지는 자세와 걸음 걸이 및 안구진탕 동반
기억장애	최근 기억과 장기간 기억에서 손상. 가역적인 뇌실과 뇌 고랑의 확장, 금주한지 1년 후에는 정상으로 됨
치매	지속되는 알코올 유도성 지속적 치매, 만성 치매환자의 20%
정신과적 증상	과도한 애도 40%, 중증 불안 10%, 피해망상 1~10%
금단증후군	2일째 가장 악화, 렘발작 rum fits, 진전섬망 등

4절. 알코올 금단(Alcohol withdrawal)

DSM-5 '알코올 금단' 진단기준

A.알코올을 과도하게 장기적으로 사용하다가 중단(혹은 감량)함
B.진단기준 A에서 기술된 것처럼 알코올을 사용하다가 중단(혹은 감량)한지 수시간 혹은 수일 이내에 다음 항목 중 2가지(혹은 그 이상)이 나타남
1) 자율신경계 항진 (예: 발한 또는 분당 100회 이상의 빈맥)
2) 손떨림 증가
3) 불면
4) 오심 또는 구토
5) 일시적인 시각적, 촉각적, 청각적 환각이나 착각
6) 정신운동초조
7) 불안
8) 대발작
C.진단기준 B의 징후 및 증상이 사회적, 직업적 또는 다른 중요한 기능 영역에서 임상적으로 현저한 고통이나 손상을 초래함.
D.징후 및 증상은 다른 의학적 상태로 인한 것이 아니며 다른 물질 중독 및 금단을 포함한 다른 정신질환으로 더 잘 설명되지 않음.

알코올 금단 임상양상

- 음주 중단 후 4~12시간 이내 시작
- 금주 48시간째 절정. 4~5일에 개선
- 금주 후 6~8시간 이내 진전 → 8~12시간 이내 정신적 및 감각적 증상 → 12~24시간에 뇌전증발작 발생 → 72시간 이내 진전섬망이 나타나기도

※ 진전섬망(delirium tremens)

- 초조, 불안증세와 함께 없는 소리가 들리는 환청, 벌레가 피부 위를 기어가는 듯한 느낌이 드는 환촉, 허공에 무엇이 둥둥 떠다니는 것 같은 환시 및 시간과 장소에 대한 개념이 없어지는 등 혼란스러운 모습
→ 의식혼탁 및 혼동 / 여러 환각 / 조잡하고 불규칙적인 진전
- 진전섬망은 마지막으로 술을 마신지 48-96시간 후에 흔히 발생하는데 적절한 치료를 받지 않을 경우 사망률이 20%에 달함.
- 불안, 불면, 자율신경계 기능저하는 3~6개월 지속될 수 있다.
- 금단 증후는 금주 12~18시간 후에 나타나서 진전섬망으로 이행되지 않는 한 5~7일 이내에 자연소실

금단 뇌전증발작(Withdrawal seizures)

- 금단 7~38시간 후 1~6회에 걸쳐 일어날 수 있음
- stereotyped, generalized, and tonic clonic
- 첫번째 발작 후 3~6시간 내에 발작이 또 나타남
- 간질지속증(Status epilepticus)은 상대적으로 드물고, 3% 이하에서 나타남
- 항전간제가 알코올 금단 발작에서 필요하지 않지만, 발작의 원인을 찾기 어렵기 때문에 대부분의 알코올 금단발작 환자들이 항전간제를 투여받고, 발작의 원인이 밝혀진 후에 중단함
- 알코올 남용의 병력이 있는 환자가 경련발작을 보이더라도, head injuries, CNS infections, CNS neoplasms, other cerebrovascular diseases을 고려해야 함
- 장기간 심각한 알코올 남용을 한 경우에는 저혈당증, 저나트륨혈증, 저마그네슘혈증으로 인하여 간질발작이 발생할 수 있음.

알코올 금단 섬망(Alcohol withdrawal delirium)

- 장기적인 알코올중독자가 갑자기 음주를 중단 또는 감량하였을 때 나타나는 섬망상태
- 입원한 알코올 중독자의 5%에서 나타남
- 음주 중단후 1~3일째에 시작하여 4~5일에 최고조에 달함
- 전구증상: 불안, 초조, 식욕부진, 진전, 공포에 의한 수면장애
- 섬망 + 진전(거칠고 불규칙함), 자율신경기능 항진, 망상, 환각, 안절부절못하는 행동, 지남력장애 + 경련발작, 발열, 단백뇨
- 환시-왜소환각 사물이 조금 작아보임
- 치료하지 않을 경우 5~15%의 사망률 보임

5절. 기타 알코올유도성 장애

- 이외에 알코올 사용으로 인해 나타나는 증상의 특성에 따라 다양한 하위 유형 존재
 - 알코올 섭취로 인해 불안장애 증세가 나타나는 알코올유도성 불안장애
 - 발기불능 등의 성기능에 어려움이 나타나는 알코올유도성 성기능 부전
 - 지속적 알코올 섭취로 치매증세가 나타나는 알코올유도성 치매
 - 알코올 유도성 우울장애, 수면장애, 기억상실장애, 정신병적 장애 등

알코올 유발 지속성 치매(Alcohol-Induced Persisting Dementia)

- 전반적인 지능, 인지능력, 기억력의 감소가 나타나며, 최근 기억장애도 전반적인 인지장애와 일치함
 - Alcohol-Induced Persisting Amnesic Disorder는 단기기억력장애만 나타남(차이점)
- 지능저하가 금주 시 다소 호전되는 경향을 보이지만, 절반 이상의 환자는 지능저하가 장기간 지속되고 심지어 영구적임
- 50~70%의 Alcohol-Induced Persisting Dementia 환자에서 뇌실의 크기가 증가하고, 뇌실질이 수축한 것으로 나타남.

알코올 유발 기억상실장애(Alcohol-Induced Amnesic Disorder)

- 알코올의 장기간 과도한 사용으로 인한 단기기억 장애
- 이 질환은 대개 수년동안 과도하게 많이 마시는 사람에게서 발생하기 때문에 35세 미만에서는 거의 없음

베르니케-코르사코프 증후군(Wernicke-Korsakoff Syndrome)

- 알코올 유발 기억상실장애의 고전적인 명칭은 Wernicke's encephalopathy(급성)과 Korsakoff's syndrome(만성)이다
 - 베르니케를 치료하지 하르면 코르사코프로 진행될 수 있다.
- 신경병리학적 병소: mammillary bodies, the thalamus, the hypothalamus, the midbrain, the pons, the medulla, the fornix, cerebellum
- 병태생리: 영양결핍이나 흡수장애로 인한 티아민 결핍
- 진행과정: 만성적 티아민(B1) 결핍 → 베르니케 뇌병증 → 카르사코프 증후군
- COAT RACK: 베르니케-코르사코프 증후군의 특징

Wernicke's encephalopathy	Korsakoff's syndrome
Confusion 의식혼란	Retrograde amnesia 후향적 기억상실
Ophthalmoplegia 안구진탕	Anterograde amnesia 전향적 기억상실
Ataxia 운동실조(비정상적 보행)	Confabulation 작화증
Thiamine deficiency 티아민 결핍	Korsakoff's psychosis 코르사코프 증후군

- Wernicke's encephalopathy : 치료하면 가역적인 상태
 - 운동실조(주로 보행장애), 전정계 기능실조, 의식혼란
 - 다양한 안구 운동장애: 수평안진, 외직근 마비, 주시마비
 - 며칠 또는 몇주안에 자발적으로 사라지거나 Korsakoff's syndrome으로 진행될수 있음
 - 초기에 대용량의 비경구적 thiamine 투여에 빠르게 반응함
- Korsakoff's syndrome: 환자의 약 20%만 회복
 - Wernicke's encephalopathy 이후에 나타나는 만성적인 건망증
 - 최근기억 상실, 전향적 기억상실증(후향적 기억상실증이 나타날 때도 有)
 - 작화증(confabulation)이 나타나기도 함(기억의 공백을 본인도 모르게 지어냄)
 - thiamine 100mg을 하루에 2~3회, 3~12개월 지속복용

※ 베르니케 뇌병증 치료

1. 티아민 투약

- 티아민 하루 필요량: 1~2mg
- 베르니케 뇌병증 치료를 위해서는 하루에 500~1500mg 고용량 투여(500mg씩 세번)
- 정주(정맥)투여: BBB 통과하여 혈액에서 뇌로 확산될 수 있도록
- 티아민 반감기는 약 96분 이하. 고용량을 하루 2~3회 투여 권장

2. 포도당이나 탄수화물은 티아민 투여 이후에 투여. 티아민 부족상태에서 포도당 부하

하면 급성 베르니케 뇌병증이 악화될 수 있음

3. 혈중 마그네슘 농도 정상을 유지. 마그네슘은 주요 보조인자로 작용

(Cf) Blackout이란?

- episodes of transient global amnesia
- 알코올 중독(alcohol intoxication) 상태에서 나타나는 전향적 기억상실
- 알코올이 해마에서 기억 공고화(장기기억화) 과정을 차단
- 다른 인지능력은 잘 보존되어 있기 때문에 복잡한 작업을 수행하고 일반 다른 사람에게 는 정상적인 것처럼 보임

알코올 유발 정신병적 장애(Alcohol-Induced Psychotic Disorder)

- 알코올중독 환자의 약 3%에서 과음 혹은 금단시에 환청 또는 편집망상.
- 가장 일반적인 환각은 환청으로 목소리가 들리는 경우가 많음. 목소리는 특징적으로 악 의적이거나 위협적임.
- 환각은 보통 1주일 미만으로 지속됨
- 음주 금단증상으로 환각이 나타나는 경우는 드물.

알코올 유발 기분장애(Alcohol-Induced Mood Disorder)

- 알코올중독환자의 80%는 2주 이상 강렬한 우울증을 호소하고, 30~40% 환자에서는 우울증의 병력이 있음.
- 과도하게 음주하지 않았을 때에도 주요우울장애 진단기준에 부합하는 경우는 10~15%
- 심각한 약물유발 우울증은 치료 없이도, 약물중단 후 빠르게 회복되는 경향

알코올 유발 불안장애(Alcohol-Induced Anxiety Disorder)

- 급성 금단 증상으로 공황발작을 80%의 알코올 중독환자에서 보고함
- 대부분 점진적으로 회복

6절. 알코올 관련 장애의 역학

알코올중독과 관련된 의학적, 정신사회적 위험

위장관	식도출혈, 말로리-와이스 파열, 장염, 장흡수장애
췌장질환	췌장염
간질환	지방침착, 알코올성 간염, 간경화
영양결핍	영양장애, 비타민 B 결핍
신경정신과적	베르니케-코르사코프 증후군, 피질위축/뇌실확장, 알코올유도성 치매, 말초신경염, 근육질환, 우울증, 자살
내분비계	고환위축, 에스트로겐 수준 증가
알코올 금단증후군	비합병증 알코올금단(떨림), 금단경련, 알코올성 환청, 진전섬망
감염장애	폐렴, 결핵
심혈관	심장근육질환, 고혈압
암	구강, 식도, 대장/직장, 간, 췌장
출생손실	태아알코올증후군
정신사회적 위험	사고, 범죄, 배우자 및 자녀유기, 직업상실, 이혼 및 사별, 법적제 제

알코올과 동반되는 장애

- ① 반사회적 인격장애: 특히 남자에게 흔하며 알코올 관련 장애에 선행해서 발병
- ② 기분장애: 알코올 관련 장애 환자의 30~40%는 평생동안 최소한 1번 이상 주요우울장애가 발생. 여자에게 흔하며 우울증이 동반되는 경우 자살률이 상당히 증가. 다른 물질 관련 장애까지 동반될 가능성이 높음. 양극성 환자들은 조증 증상을 스스로 조절하기 위해 술을 자가복용하는 경우가 있어 알코올 관련 장애가 동반될 위험이 높음.
- ③ 불안장애: 불안증상을 경감시킬 목적으로 음주. 불안장애가 동반되는 경우는 20~25%로 추정, 그 중에서도 공포증이나 공황장애에서 흔히 동반.
- ④ 다른 물질남용: 알코올의 다른 남용물질을 주로 니코틴의존, 즉 흡연이 많음. 이는 대개 알코올의 중추신경 억제작용을 강화.
- ⑤ 폭력과 자살: 알코올 관련장애는 사고, 폭력, 자살 등의 위험성이 매우 높음. 알코올 관련 자살률은 10~15%정도. 특히 알코올 중독에서의 자살은 만성 알코올 중독에 따른 우울증 때문이기도 함

예후

- 예후가 좋은 경우
 - 반사회적 성격장애나 동반된 물질사용장애가 없는 경우
 - 안정된 직장고 가정고 있고 알코올과 연관된 법적인 문제가 없는 경우
 - 치료가 집중적으로 이루어지는 초반(첫 2~4주)에 환자가 중도탈락하지 않고 협조적인 경우

- 첫 1년의 단주 성공은 그 이후의 지속적인 단주유지와 연관이 있음

6절. 알코올 관련 장애의 역학

7절. 알코올 관련 장애의 선별

문제성 음주의 여부 선별 도구 - CAGE

1. **C**ut: 술을 끊겠다고 결심한 적이 있다.
2. **A**nnoyed: 가족이나 주변 사람에게 술 때문에 질책을 받고 짜증을 낸 적이 있다.
3. **G**uilty: 술 문제로 인해 죄책감을 느낀 적이 있다.
4. **E**ye-opener: 해장술을 하거나 오전에도 술을 마시는 경우가 있다.

- 4가지 중 2개 이상 해당한다면 술로 인한 문제가 심각

문제성 음주의 여부 선별 도구: AUDIT-K

질 문	0점	1점	2점	3점	4점
1. 얼마나 자주 술을 마십니까?	전혀 안마실	월1회 이하	월2-4회	주2-3회	주4회
2. 술을 마시면 한번에 몇잔 정도 마십니까?	전혀 안마실	소주 1-2잔	소주 3-4잔	소주 5-6잔	소주 7-8잔 (10잔 이상 5점)
3. 한번에 소주 한병 또는 맥주 4병 이상 마시는 경우는 얼마나 자주 있습니까?	없음	월1회 미만	월1회	주1회	거의 매일
4. 한번 술을 마시기 시작하면 멈출 수 없었던 때가 1년동안 얼마나 자주 있었습니까?	없음	월1회 미만	월1회	주1회	거의 매일
5. 지난 1년간 평소 말으면 할 수 있었던 일을 음주 때문에 실패한 적이 얼마나 자주 있었습니까?	없음	월1회 미만	월1회	주1회	거의 매일
6. 지난 1년간 술마신 다음날 일어나기 위해 해장술이 필요했던 적은 얼마나 자주 있었습니까?	없음	월1회 미만	월1회	주1회	거의 매일
7. 지난 1년간 음주 후에 죄책감이 든 적이 얼마나 자주 있었습니까?	없음	월1회 미만	월1회	주1회	거의 매일
8. 지난 1년간 음주 때문에 전날 밤 일이 기억나지 않았던 적이 얼마나 자주 있었습니까?	없음	월1회 미만	월1회	주1회	거의 매일
9. 음주로 인해 자신이나 다른 사람이 다친 적이 있습니까?	없음		있지만 지난 1년간은 없었다		지난 1년간 있었다
10. 친척이나 친구, 의사가 당신이 술 마시는 것을 걱정하거나 당신에게 술 끊기를 권유한 적이 있었습니까?	없음		있지만 지난 1년간은 없었다		지난 1년간 있었다

- 총점

- 10점 미만: 정상
- 10~19점: 고위험 음주자(여성: 6~9점)
- 20점 이상: 알코올 사용장애(여성: 10점 이상)
- 간단한 버전: 3번까지만 평가
- 8점 이상: 문제성 음주
- 9점 이상: 알코올 사용장애

7절. 알코올 관련 장애의 치료, 재활

1. 평가

- 평가 후에 입원, 낮병동, 외래내원할 것인지 결정해야 함
- 자살, 타살 우려
- 동반된 정신과적 장애
- 간경화 및 위장관출혈, 영양결핍, 대사장애

2. 약물치료

- 중독(intoxication) 치료
- 금단 증상의 치료
- 동반한 정신 증상의 치료

3. 치료

- 환자 교육
- 인지행동치료
- 행동치료
- 집단치료
- 자조집단과 12단계 프로그램

알코올 중독으로 벗어나기 위한 중요 원칙

1. 자신이 중독자임을 받아들이기

- 술을 좀 줄이거나 적당히 조절해서 마셔보겠다는 생각은 망상과 같음
- 이미 알코올 중독이라는 질환에 걸렸다는 것은 술에 대한 조절능력을 상실했다는 것을 의미하며 그렇기에 완전한 단주만이 유일한 해결책임을 이해하고 받아들여야함.
- 알코올 중독이라는 것이 알코올 사용의 조절력을 상실한 상태이므로 적당한 사용이 아닌 완전한 사용 중지를 해야한다.

2. 단순한 의지와 결심만으로는 안된다.

- 술로부터 벗어나는 방법들을 배우고 실천
- 술 관련 자극을 피하고, 전문가 상담, 자조모임, 신앙생활 등 삶의 변화
- 가족 교육: 알코올 중독 이해, 태도 변화
- 뇌의 반응 사진 기억하시죠?

치료

1. 개입(intervention)

- 직면(confrontation): 환자로 하여금 알코올 의존이라는 질환으로 인한 부정적인 결과들을 정확하게 인식하고 지금이라도 치료받지 않으면 더 심화될 것이라는 사실을 직시하도록 함
- 알코올 의존이라는 문제를 부정해버리고 싶은 환자의 저항을 넘어서서 환자에게 치료동기를 부여함
- 환자가 먼저 불편하다고 호소하는 문제(예: 불면증, 성기능장애 등)에 초점

2. 해독(detoxification): 처음 병원에 올 때는 급성기인 상태로 실려오는 경우가 많다.

- 안정, 충분한 수분, 영양공급, thiamine 포함한 비타민 공급
- 자해 혹은 타인을 해칠 수 있는 과격한 행동 시 haloperidol(2~5mg)을 경구, 정맥주사 투여 혹은 신체적 구금도 필요함.
- 환자가 섬망상태에서 탈진할 가능성이 있으므로 부득이한 경우를 제외하고는 신체결박은 하지 않음.
- 알콜금단증상은 대개 입원치료함: 안정, 수액공급, 전해질 교정, 영양 공급, 비타민 공급. benzodiazepine 사용

정신치료

- 정신치료의 목표는 병명을 정확히 알려주어 병식을 갖게 하는 것(주변 사람들에 의해 입원하는 경우가 많다. 이 경우 본인은 정신과 환자가 아니라는 생각에 억울하고 분노를 표출할 수 있다.)
- 술 마시는 상황, 술 마시게 되는 동기, 술 마신 후 예견되는 결과에 초점을 두어 상호 신뢰를 바탕으로 하는 적극적인 지지적 정신치료가 필요하며, 가족치료, 동질 집단의 집단치료도 병용
- 인지 행동 치료 및 사회 기술 훈련, 동기 강화 치료 등
- 행동 치료는 불안을 감소시킬 수 있는 음주 이외의 다른 방법을 사용하는 것으로, 이완 훈련과 자기주장 훈련

약물치료

- 알코올리즘의 원인이 되는 우울증, 공황, 불안에 대한 약물 치료
- 항갈망효과로 아편양제제 길항제: 날트렉손, 아캄프로세이트(재발가능성 및 재발기간 줄임)
- 디설피람: 알코올 대사 산물 중 독성 물질인 아세트 알데히드의 대사를 방해 신체적 불편감을 작위적으로 증가시키는 혐오요법(숙취 오래 가게 함)
 - 부작용: 심장, 뇌경색, 당뇨, 고혈압 환자에게 위험

자조집단

- 모든 환자에게 단주친목(AA)에 참여하도록 적극적으로 권유
- 배우자에게는 알코올 가족친목(AI-Anon), 자녀들에게는 알코올 자녀친목(Alateen)참석을 권유할 수 있다.
- **알코올 사용장애들에게 강조되는 방법**

재활

1. 금주에 대한 높은 동기를 가지며 유지할 수 있도록: 알코올 중독에 대한 교육과 환자 가족과 친구들에게 알코올 문제로부터 더 이상 보호해주지 말라고 교육(**가장 중요**)
2. 술 없이 적응할 수 있도록 개인적 상담, 직업 재활, AA 같은 자조 그룹 등을 통해 생활 방식 재확립
3. 재발방지: 음주 가능성이 있는 상황을 인지하고 그러한 위험을 다루는 방법을 확립하는 것, 다시 음주하였을 경우 단주할 계기를 증가시키는 전략을 발달
4. <http://www.aakorea.org/>

재발 방지를 위한 전략

1. 자신의 알코올 문제가 심각하다는 철저한 자기 인식(**가장 중요**)
 2. 알코올 중독에서 회복하는 유일한 길은 완전히 술을 끊는 것. 평생 단주
 3. 술을 마시지 않고도 생활할 수 있는 자신만의 방법을 찾기(**술을 마시는 이유가 사람마다 있음. 술에 의존하지 않고 삶에 대처할 수 있는 방법을 찾아야 한다.**)
 4. 자기주장훈련, 문제해결기술훈련, 감정조절을 위한 방법, 거절할 수 있는 자기표현 능력 프로그램 등을 통해 부족한 사회기술을 익혀야 함
- 지금이 미래를 변화시킬 가장 빠른 시간이라는 사실

※ 사례1

정신병원 알코올병동에서 퇴원한 후 7년 넘게 단주를 유지하고 있다.

자신은 중독자가 아니라고 생각했지만 병원 입원 후 중독자라는 사실을 받아들이게 되었다.

첫 입원 시 폐쇄병동에 입원했을 때의 충격이 커서 단주를 결심하였다. 병원치료자가 알코올 회복프로그램에 열심히 참석하면 퇴원할 수 있다고 해서 그렇게 하였고, 동료 환우들의 잦은 입·퇴원이 병원 의존증으로 보여 이를 반면교사로 삼았다. 퇴원 후에도 치료진과 친밀한 관계를 유지하였다.

회복과 관련하여 궁금한 것이 있으면 SNS로 연락하였고, 그 이후에 알코올중독 회복자였던 치료진과 재혼하였다. 재혼 후 남편과 함께 AA모임에 참석하였으며 남편은 든든한 후원지역할을 하였다. 남성들이 대부분인 AA에 불편함을 느끼고 쉽게 적응하지 못했으나, 남편과 함께 지속적으로 참석하다 보니 적응이 되었다고 하였다. 그녀는 식당에서 아르바이트를 하며 손님과 갈등이 있을 때 음주충동이 일어남을 알게 되었고, 이는 AA모임을 더욱 열심히 다니게 되는 계기가 되었다. 이후로 마음 속에서 술을 없애며 갈망감이 사라졌다. 단주기간이 길어지면서 소원했던 형제들을 먼저 찾아다니며 화해하였고, 또 다른 회복자를 위해 메시지를 전달하는 봉사를 하고 있었다.

※ 사례2

정신병원 알코올병동에 총 2회의 입·퇴원을 반복하였고 단주생활을 13년째 유지하고 있다.

그는 술을 좋아하며 남자다운 면모를 가지고 사업 수완이 좋아 건축업에 종사하였다. 일을 하며 술을 마셨지만 술 문제를 전혀 인식하지 못하였다. 보다 못한 아내가 그의 술 문제를 해결하여 위해 먼저 중독자 가족모임(AI-Anon)에 다니면서 입원할 수 있게 되었다. 입원 시 알코올 치료프로그램에 참여하면서 술 문제에 대한 병식이 형성되었다. 3개월간 중독 관련 프로그램에 참가하고 입원 중에도 AA에 참여하는 등 회복을 향해 한 발짝 나아가기 시작하였다.

퇴원 후 단주생활을 하다가 1년 만에 재발을 경험하였다. 사기를 당해 화가 나 있는 기간이 3개월이나 되었고 결국 술을 마셨다. 한번 마신 술을 멈추지 못하고 20일 연속해서 마셨고, 결국 스스로 응급입원을 선택하였다. 왜냐하면 입원해 본 경험이 있어 또 다시 입원을 해야만 자신이 살 수 있으리라는 판단이 들었기 때문이다.

그 이후 AA에 열심히 다니며 단주생활을 하다 5년 만에 또 다시 재발하였다. 기분이

좋아서 그만 소주 서너 병을 마셨는데 후회가 되어 바로 A.A모임에 참석하여 마음을 다잡았다고 하였다. 그러나 자신이 5년 만에 재발한 사실을 가족 말고는 아무도 모르고 있으며, 잠시 넘어진 그때 A.A가 있어 일어설 수 있었다. 곁에 있던 아내도 큰 힘이 되었다.

또한, 단주를 하며 경제활동이 가능해지자 가족에게 인정받게 되었고, 아버지 자리를 되찾은 그는 과거 음주 시 자신이 했던 잘못을 가족에게 사과하였다. 이후 AA는 그의 인생에 없어서는 안 될 존재가 되었다. AA 대표봉사, 한국연합 봉사를 수 년간 해왔으며, 이 일을 당연히 해야 할 것으로 알고 있었다. 현재도 AA에 반드시 참석하고 있었다. 그러나 AA에서 파벌이 형성되자 불편한 마음을 드러내 보였다.

사례 분석결과

1. 음주로 인한 신체적 고통과 병원 치료프로그램을 통한 질병 인식은 중요한 회복동기
2. 치료진에 대한 신뢰는 알코올중독 회복의 중요한 요소
3. A.A가 알코올중독 회복에 미치는 영향은 긍정적으로만 작용하지 않았다
4. 참여자들은 회복과정에서 습관적으로 단주 이전의 삶으로 돌아가고 싶은 유혹을 느꼈다
5. 참여자들은 단주로 가족 및 주변 사람들과 관계가 호전되었고, 취업하여 경제적 안정을 되찾으면서 그들로부터 인정을 받게 되어 비로소 자신의 존재를 확인할 수 있었다
6. 각 참여자들이 회복과정에서 음주갈망을 느끼는 정도와 그것의 재발과의 관련성에는 다소 차이가 있다
7. 참여자들은 회복 중에 다양한 심리적 위기와 알코올중독 후유증을 경험 : 낙인, 성인이아 이, 신체적 장애, 건강염려증과 공황장애와 같은 중독 후유증을 경험
8. 가족의 지지는 알코올중독 회복에 도움이 되는 중요한 요인. 특히 여성참여자들에게 알코올 중독 치료에 대한 배우자의 협조와 지지는 회복에 큰 도움
9. 참여자들은 퇴원 후 A.A모임 이외에도 비공식적 회복모임, 장애인센터, 중독센터 등 지역사회자원을 적극 활용하여 단주생활을 유지

알코올중독자들의 회복경험에 대한 의미단위, 범주와 주제

주 제	범 주	의미단위
자기성찰을 통해 술을 포기함	부경	중독문제를 인정하지 않음/치료에 강한 저항
	충격	자신이 중독자임을 알게 됨
	분노	술을 끊으면 낙이 없음/술을 계속 마시면 단명한다고 함
	후회	술 마시고 인생을 값없이 살았음/속없이 살아온 내 모습 이 보임
	의심	난 안 될 것 같은 사람/나도 나를 못 믿어
단주 열망으로 가독함	수용	단주는 내 몫/단주가 어렵다는 것을 받아들임
	희망이 보임	새로운 인생을 살아보고 싶음/헤어진 자녀들을 볼 수 있음
	인정받고 싶음	회복자가 되고 싶음/사랑받고 관심 받고 싶음
	회복에 적극적임	A.A. 모임이 생활의 중심이 됨/등산과 운동을 열심히 함
중독의 늪에서 빠져나오기	A.A.에 대한 두마음	A.A. 모임에 대한 신뢰 상실/A.A. 회원들의 불협화음
	가족의 지지	믿고 기다려줌/조건 없는 지지
	경제적 어려움 극복하기	검소한 삶/새로운 직장을 구함
	새로운 관계 형성	회복자와 친해짐/회복자들로 친구들이 바뀜
	나를 변화시키기	제대로 살아보고 싶음/생활습관을 바꿈
상처를 끌어안고 새로운 삶에 충실함	갈망 다스리기	이유 없이 쳐들어오는 갈망을 다스림/갈망을 미리서 차단함
	재발에 대한 대처	재발경고증상을 알아차림/무너지면 끝이라는 생각
	중독 후유증	건강염려증/낙인/성인이아
	변화와 발견	가족관계가 원만해짐/실수가 사라짐
	다시 일어섬	세상살이에 책임감이 생김/삶의 의미 발견

8절. 중독과 트라우마

아동기 부정적 경험(ACE)와 약물중독과의 관계

- 어린 시절 트라우마를 겪은 알코올 장애 환자들은 더 심한 정서장애를 경험하고 치료 효과도 낮고 재발률도 높다.
- 가족 같은 강한 유대 관계에서 비롯된 트라우마일수록 문제 해결 능력의 저하와 심각한 알콜 문제를 일으킬 위험이 높다.

트라우마 (자신의 존재를 부정하게 만드는 위협적인 경험)	- 전쟁 같은 일상에서 죽을까봐 두려워함(학대) - 물질적 궁핍으로 인해 선택지가 없어 막막함 - 성폭력 경험으로 인해 존재가치를 상실함 - 방임, 무관심 속에서 기본적 욕구가 충족되지 않음
중독 (자아의 생존을 위한 유일한 도피)	- 중독의 DNA에 자연스럽게 자신을 내맡김 - 지옥 같은 고통을 피해 또 다른 고통 속으로 도망침 - 살아내기 위해 중독물질과 아슬아슬한 관계를 맺음 - 스트레스 상황 속에서 적절히 대응하는 방법을 찾지 못해, 지옥 같은 상황에서 벗어나는 해결책으로 중독 물질을 찾게 됨
회복 (지지 속에서 잃어버린 자아를 찾아가는 여정)	- 중독의 근원이 트라우마임을 알아채고 자신을 수용 - 용서와 봉사로 상처를 치유하면서 삶의 의미 찾음 - 상처를 딛고 관계를 회복해 나감 - 다양한 도움의 손길을 받으며 세상과 연결됨

알코올 중독자의 (성인)자녀 ((A)COA)

- (Adult) Children of Alcoholics
- 부모 음주문제 → 정서적 지지 부재
- 존경하지 못하는 부모의 존재에 대한 혼란스러움
- 음주 문제로 비롯된 가정 내 폭언, 폭행 → 무기력 학습
- 고립감, 환영받지 못하는 존재로 스스로를 인식
- 성인이 되어도 스스로를 돌보지 못하고 부모의 알코올 중독의 문제가 자녀에게도 되물림, 중독 문제 발생

- 중독자 자녀의 4가지 유형(Sharon wegscheider)

- ① 가족영웅: "내가 모든 것을 잘해야 아버지가 행복하고 술을 드시지 않을거야".
책임감, 자기희생
- ② 속죄양: 중독의 관심을 돌리기 위해 가출, 절도, 음주, 비행 등 반사회적 운동
부정적 행동이 가족을 결속시킨다고 믿음
- ③ 잊혀진 아이: 투명인간, 아무런 요구도 문제도 일으키지 않음
혼자만의 시간, 숨어있기, 대인관계 어려움
- ④ 마스코트: "걱정마, 내가 어른이 될 때 이 모든 것을 기억하지 않을게"
애교, 유머, 광대의 역할. 겉으로는 미소, 속으로는 눈물

[3] 담배관련장애

DSM-IV-TR NICOTINE-RELATED DISORDERS	DSM-5 Tobacco-Related Disorders
Nicotine Use Disorder Nicotine Dependence	Tobacco Use Disorder Tobacco Withdrawal
Nicotine-Induced Disorder Nicotine Withdrawal	Other Tobacco-Induced Disorders
Nicotine-Related Disorder NOS	Unspecified Tobacco-Related Disorder

1절. 개요

- 흡연자는 약 47%: 미국 12세 이상 인구 중 27.4%가 담배 관련 물질 사용자
- 정신과 환자 중에 흡연자가 多: 외래환자의 50%, 외래 양극성 장애환자의 70%, 외래 조현병 환자의 90%
- 니코틴: 중추신경계 자극제. 심장박동 증가, 혈관수축, 혈압상승, 피부온도 강하 등의 신체적 변화 초래
- 적당량 섭취: 성 수준이 높아지고, 주의나 학습 기능 향상, 우울한 기분 완화
- 과도한 섭취: 메스꺼움, 구토, 무력감, 복통, 설사, 떨림, 두통, 빈맥, 고혈압, 진땀, 주의집중장애, 착란, 감각장애, 수면곤란 등 심하면 호흡마비로 사망할 수 있음.

담배 금단증상(Tobacco withdrawal)

- 금단 후 90~120분부터 나타나기 시작하여 24~48시간에 최고조에 달하여, 몇 주, 몇 개월간 지속됨.
- 담배에의 갈망, 긴장, 불안, 주의집중장애, 두통, 졸음, 수면장애, 소화기계장애, 쉽게 화를 냄, 맥박감소, 혈압감소.

치료 = 금연

- 1년 후까지 금연에 성공하는 사람은 3~5%에 불과함
 - 6개월 내 50%, 1년 내에 75%가 다시 피움
 - 1년이 지나도록 금연할 수 있으면 성공률은 매우 높아짐
- 동기강화치료, 인지행동치료, 최면, 혐오요법, 집단치료, 니코틴 대체치료, 비니코틴 약물 치료: 전반적인 성공률이 대개 15~30%

약물치료

1. 니코틴 대체제: 니코틴에 대한 갈망과 금단 증상을 제거.

- 니코틴 패치: 하루에 한 번만 붙이면 되서 간편함. But 효과가 미약함
- 니코틴 껌: 껌에 대한 의존이 발생할 수 있음.
- 니코틴 비강분무제, 흡입제
- 니코틴 정제

2. 바레니클린(챔픽스): 니코틴 수용체 선택적 작용제

- 도파민을 보상하는 작용을 차단시키는 약물
- 금연 시작 1주일 전부터 3일간 0.5mg 처방, 1mg 증량하여 4일간 사용, 이후로 2mg으로 증량하여 12주간 투약함

3. 정신과 약물

- 부프로피온 300mg: 항우울제. 금단증상을 억제
- 금연시 투여 중인 정신과 치료약물(imipramine, desipramine, clomipramine, nortriptyline, fluvoxamine, clozapine, haloperidol, propranolol 등)의 농도가 상승할 수 있음(흡연 자체가 정신과 약물의 혈중 농도를 감소시키기 때문에 투여용량을 늘려야 한다. 반대로 금연하게 되면 다시 용량을 조절해야 한다.)

	부작용	금기 및 주의사항
니코틴 대체제	- 수면장애/꿈 이상 - 오심/구토, 기타 위장장애 - 두통, 어지럼증 - 혈압상승, 심계항진/흉통	<주의사항> - 심혈관질환자: 최근 2주 이내의 중증 심혈관계 질환(심근경색, 불안정성 협심증, 심한 부정맥, 뇌졸중 등)을 가지고 있는 경우 - 활동성 소화성 궤양
바레니클린	- 오심/구토 - 수면장애/생생한 꿈 - 변비, 고장 - 두통 - 기분 및 행동변화, 자살생각	<주의사항> 18세 미만 청소년, 임신부나 수유부의 경우 안전성이 검증되지 않아 권장되지 않음 - 신장을 통해 배설되므로, 신장 기능이 떨어진 흡연자(GFR<30mL/min)나 투석 중인 경우에는 용량을 줄여야 함
부프로피온	- 불면 - 구강 건조 - 두통 - 조조, 신경과민 - 소화불량 - 변비 - 식욕변화	<금기> - 경련질환의 병력 - 중추신경계 중양, 심각한 두부손상 - 양극성 장애(조울증) - 거식증 또는 폭식증(섭식장애)의 병력 - 심한 간기능 이상자

[4] 비물질관련장애(non substance related disorders)

1절. 도박장애(Gambling disorder)

- DSM-5에서는 비물질관련장애로 도박장애를 포함
- 도박장애: 노름이나 도박을 하고 싶은 충동으로 반복적인 도박을 하게 되는 경우로 병적도박이라고도 함.
- 시간이 지날수록 도박에 거는 액수가 커짐 (내성) + 도박을 못하게 할 경우 우울, 불안, 안절부절 등 (금단증상)
- 남성의 경우 초기 청소년기에, 여성의 경우 주부 도박단처럼 인생의 후기에 시작
- 우울증의 변형된 상태, 도박을 그만두면 우울하고 불쾌한 내면적 상태의 도피 수단
 - 도박을 하면 교감신경계가 활성화, 주관적 흥분감이 증가하여 기분이 좋아지고 피로감이 줄어들어 자신을 괴롭히는 부정적 정서상태에서 벗어나

DSM-5 도박장애 진단기준

A.지속적이고 반복적인 문제적 도박 행동이 임상적으로 현저한 손상이나 고통을 일으키고 지난 12개월 동안 다음의 항목 중 4개(또는 그 이상)가 나타남

- 1)원하는 흥분을 얻기 위해 액수를 늘리면서 도박하려는 욕구
- 2)도박을 줄이거나 중지시키려고 시도할 때 안절부절못하거나 과민해짐
- 3)도박을 조절하거나 줄이거나 중지시키려는 노력이 반복적으로 실패함
- 4)종종 도박에 집착함 (예: 과거의 도박 경험을 되새기고, 다음 도박의 승산을 예견해 보거나 계획하고, 도박으로 돈을 벌 수 있는 방법을 생각)
- 5)괴로움(예: 무기력감 죄책감 불안감 우울감)을 느낄 때 도박함
- 6)도박으로 돈을 잃은 후, 흔히 만회하기 위해 다음날 다시 도박함(손실을 쫓아감)
- 7)도박에 관여된 정도를 숨기기 위해 거짓말을 함
- 8)도박으로 인해 중요한 관계, 일자리, 교육적 직업적 기회를 상실하거나 위험에 빠뜨림
- 9)도박으로 야기된 절망적인 경제 상태에서 벗어나기 위한 돈 조달을 남에게 의존함

B.도박 행동이 조증 삽화로 더 잘 설명되지 않음

- 교수님曰: DSM-5 진단기준은 참고로 보세요~

2절. 인터넷 게임장애

- DSM-5에는 추가 연구가 필요한 부적응 형태로 제시되어 있음
- ICD에서는 중독 행동으로 인한 장애의 하나로 포함
- 다른 활동은 소홀히 하고 하루 8-10시간 이상, 한 주에 적어도 30시간 이상 게임
- 게임을 하지 못하도록 하면 불안해하고 분노함.
- 생물학적 요인: 중독에 취약한 유전적 기질과 신경생리적 결함, 다른 정신장애 공존

게임중독과 공존질환상호관계

- ADHD: 자극추구성향. 자극이 없으면 집중하기 어렵다. ADHD 동반된 게임중독이 더 만성적, 회복률 낮음.
- 우울증: 게임으로 소통, 즐거움
- 조울증: 조증상태에서 게임에 몰두
- 아스퍼거 증후군: 대인관계의 어려움. 가상현실세계에 만족

[4] 酒傷證,중독, 금연

1절. 개요

酒

- 氣熱質濕한 성질 → 濕熱
- 風寒을 방어하고
- 血脈 宣通시키고,
- 邪氣를 消滅하며,
- 藥力을 引導

酒傷證

- 음주로 인하여 발생하는 모든 질환
- 종류: 酒風, 酒悖, 酒疸, 酒癰, 酒積, 酒厥, 酒癰, 酒癰, 酒泄, 酒嗽, 酒痰, 酒齕

<證治彙補> 經絡 및 臟腑別 酒傷 證候 (경락 및 장부별 주상 증후)

區分 / 臟腑	入經絡	傷臟	腑受之
肝(膽)	善怒有力	脇痛吐血	面青
心(小腸)	多笑多言	怔忡不寐	溺多
脾(胃)	思睡	痞滿疸脹	汗多
肺(大腸)	多嚏多痰	咳嗽消渴	赤利
腎(膀胱)	思淫	腰軟陽痿	尿赤

- 과거 국시 단골 문제였지만 시험에는 안 내신다고 합니다.

2절. 증후

주패(酒悖)

- 간부담횡(肝浮膽橫)하게 되어 사람이 광패변노(狂悖變怒)하며 그 평상시의 성격까지 변하게 되는 것으로 惡酒候
- 술먹고 난리 치는 사람. (悖는 패악질 할 때의 패입니다.)



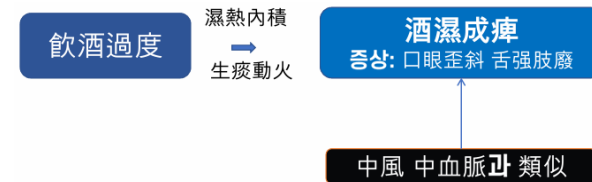
주궤(酒厥)

- 大醉한 후, 홀연 전율(戰慄)하고 수족궤냉하며 不省人事하는 것
- 술을 몽땅 먹고 갑자기 정신을 잃고 쓰러지거나, 몸이 떨리게 되고 손발이 차가워지고 인사불성하는 것



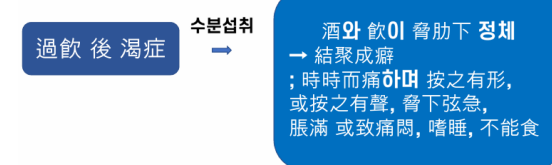
주습성비(酒濕成痺)

- 음주과도로 濕熱內積하고 生痰動火하여 發.
- 구안와사(口眼歪斜) 설강지폐(舌強肢廢)한 것이 中風의 中血脈과 유사
- 중혈맥: 풍사가 혈맥에 들어온 것으로 구안와사가 생기며 중한 병으로 반신불수가 되고 소변의 장애를 동반



주벽(酒癖)

- 음주 후 갈증으로 수분을 섭취한 후 酒와 飮이 脅脇(脅肋)하에 정체되어 벽(癖)이 된 것
- 때때로 통증이 있고 누르면 형체가 만져짐. 허리가 아프기도 하고 옆구리 아래가 땡기기도 하고 창만하면서 속이 창만하면서 답답한 증상. 잠만 자려함, 밥을 잘 못먹음



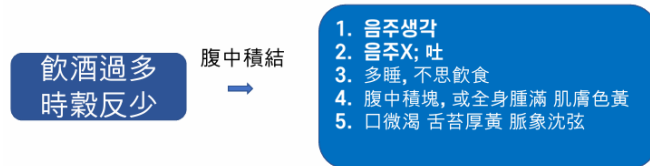
주징(酒癥)

- 술을 너무 즐겨 과음을 계속하면서 복부에 癥塊(징괴)가 생기는 것
- 간의 문제로 종괴 등이 생긴 것



주가(酒瘕)

- 음주과다하나 대신 밥을 적게 먹어 腹中積結하여 생기는 것으로 항상 음주만 생각함
- 술을 먹지 않으면 토하고, 많이 자고, 식사할 것을 생각하지 않고 복중에 적과가 있음
- 알코올 중독에 해당



3절. 주상증의 치료

- 유형별로 구체적으로 치료하는 것은 읽어보라고 하십니다.

개요

- 급성기
 - 우선 吐法과 發汗法을 사용
 - 깬 후에는 利小便하여 濕熱을 제거
- 만성기
 - 酒傷 治法을 기본으로 하되 합병증의 유형에 따라 經絡과 臟腑를 구분하여 치료
- 치료개요: 열을 제거하기 위해 發汗하고, 열이 제거된 후 남은 濕은 利小便하여 제거
 - 發汗: 葛花解醒湯 갈화해성탕
 - 滲劑: 五苓散 오령산
 - 調中: 二陳湯 이진탕
 - 長期飲酒로 內熱, 腹痛, 大便窘迫: 酒蒸黃連丸 주증황련환

주결

- 급히 옷을 벗기고 몸을 흔들어서 무수히 토하도록 하면 깨어나는데, 溫湯에 全身을 담가서 늘 따스하게 하여야 한다.
- 만약 冷水에 들어가면 卽死한다.
- 葛根을 찢어汁을 내어서 입 속에 넣는다. (동의보감)
- 임상적으로 별로 안 씀

취후두통(醉後頭痛)

- 冲和湯 (證治要訣)
- 對金飲子 加 乾葛, 赤茯苓, 半夏 各一錢 (東醫寶鑑)
 - 뇌에 신경세포의 생성이나 회복을 돕고 기억력과 학습능력 저하를 방지한다. + 청간해조탕도 자주 쓴다.
- 防風通聖散 방풍통성산 加 黃連 二錢, 連鬚 葱白 十莖 (東醫寶鑑)

음주발열(飲酒發熱)

- 黃連解毒湯加葛根 (동의보감)
- 酒蒸黃連丸 (醫學入門)
- 黃芩芍藥湯, 清化飲, 從薪飲 (景岳全書)

주징. 주벽

- 酒積: 酒癰圖, 紅圓子
- 酒癖: 倍朮湯, 消飲圓 (太平惠民和劑局方)
- 多飲 結成酒癖: 冲和湯加蓬朮半錢 (證治要訣)

음주기벽(飲酒嗜癖)

- 알콜 남용 및 의존을 말하며 주가증(酒瘕症)과 유사

1. 吐法

2. 약물요법: 가미대금음자(청피 20g, 백하수 10 12~20g, 진피, 갈근 각 12g, 후박, 창출, 감초, 적복령, 사인, 신국 각 4g)

- 뇌에 신경세포의 생성이나 회복을 돕고 기억력과 학습능력 저하를 방지한다.

- 청간해조탕도 자주 쓴다.

3. 이침요법

- 금주: 醉點, 枕, 皮質下, 額點

- 알코올중독

- ✓ 기본점: 숙취점, 간, 폐2, 뇌, 제로점, 신문, 후두골

- ✓ 보조점: 자율점, 내분비점, 신경안정점, 주뇌점, 주진동점, 갈증점, 변연계, 공격점, 항우울점

- 미주신경자극술과 연관지어서 이침을 중독환자들에게 같이 적용해볼 수 있다. 전침을 같이 걸어줘서 비슷하게 시술

酒傷에서의 忪怔不寐 및 癲狂

- 주병이 오래되어 내장으로 들어가 심과 간담에 침입하면 정충불매, 혼광망구하는 현상을 일으킬 수 있음
- 알코올성 환각증, 알코올 금단증후 등의 정신병적 장애
 - Alcohol Withdrawal Delirium
 - Alcohol-Induced Psychotic Disorder
 - Alcohol-Induced Mood Disorder
 - Alcohol-Induced Anxiety Disorder
- 금단증후군: 단주 4~12시간부터 시작, 이틀째 절정, 4~5일째 개선
섬망이나 경련을 동반하면 위험해질 수 있다.

酒傷에서의 癇病

- 만성음주자의 약 10%에서 재발성 간질
- Withdrawal Seizures
- 금단경련증: 단주 7~38시간에 일어날 수 있고 약 24시간 내 흔히 발생, 중첩발작은 약 3% 미만

4절. 中毒

- 지금은 이런 걸 활용하지 않는다.

중독의 치료원칙

- 우선 毒物의 더 이상의 흡수를 방지하고 흡수된 毒物을 체외로 배설하며 대증요법과 전신 해독제요법을 적절히 실시하는 것
- ① 病毒이 上部에 있으면 吐法
- ② 病毒이 下部에 있으면 下法
- ③ 病毒이 이미 흡수된 경우에는 和法
- ④ 해독제가 있는 경우 투여 / 없는 경우 생명유지에 필요한 기본 처치 및 간호 시행, 원인 물질에 따른 처치나 해독요법 병행

5절. 한의금연치료

개요

- 금연치료의 3단계
 - ① 흡연 욕구 억제 치료
 - ② 금단 증상 개별 치료
 - ③ 폐기능 활성화 치료

! 5A 전략 시표



- 한의원 내원시 5A 전략을 사용한다.
- 금연동기를 유발하는 것이 중요하기 때문에 5R 전략을 활용한다.

1단계: 흡연 욕구 억제 치료

- 특히 심혈관계 질환자, 청소년, 임산부 등의 경우 금연 치료 약물에 대한 안전성의 문제로 금연 침 치료를 적극 권장할 수 있음
- 금연 치료 약물 및 정신행동요법을 이미 시행하고 있는 경우 이침을 추가 시술하여 효과를 더욱 높일 수 있음
- 금연치료 약물을 이미 시행하고 있으나 약물의 부작용이 나타나는 경우 금연 침 치료 등을 통해 약물의 부작용을 낮추고 순응도를 높일 수 있음

- 이침치료

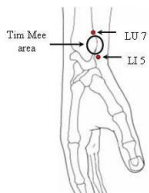
- 귀의 연결은 혈액 공급이 원활하지 않기 때문에 감염을 피하기 위해 일반적인 정침법을 준수하여 시술한다
- 연결 손상을 방지하기 위해 심자를 피하고 자침 시 주의깊게 시술한다.

- 피내침을 이용하여 매침하는 경우 심내막염이 있는 환자는 피한다.
- 혈위: 내분비, 신문, 신, 간, 폐

이침	
혈위	<다음의 혈위 등에서 선택> 肺, 神門, 口, 咽喉, 內鼻, 內分泌 중 4~6혈
시술법	혈위 소독 후 매침, 좌우 번갈아가면서 시술
기간	주 2회 실시, 총 12회 한 세트(6주)
환자티칭	매일 3-6회 누름 (흡연욕구 발생 전부터 수시)
효과	흡연욕구를 줄여주며, 흡연자가 느끼는 담배맛을 변화시킴

체침	
혈위	<다음의 혈위 등에서 선택> - 족삼리, 신문 - 열결, 영향, 합곡, 공최, 합곡, 침미
시술법	호침 자입해 득기감 유발 후 유침 20-30분 전기자극 가능 이침과 병행가능
기간	- 1 session = 주 2회, 총 12회, 6주 치료 - 2 session 시행 이후 금연 여부 평가 후 치료 종결 및 추가 2 session 여부 결정 - 추가시행 시 주 1-2회 실시, 6주 치료

- 족삼리 전침자극
- 신문혈 자극
- 침미혈: 열결혈과 양계혈 사이에 위치. 해당 부위에 침 혹은 뜸치료를 시행하면 흡연 욕구를 감소시키며 흡연으로 인한 咳嗽, 口渴, 口苦, 頭暈 등 증상이 개선된다고 알려져 있음



2단계: 금단증상 개별치료

① 불안(심계정증, 발한, 심통, 진전, 백합병, 장조증)

- 온담탕 加減: 반하 9g, 진피 10g, 죽여 12g, 기실 10g, 황련 9g, 치자 10g, 복령 20g, 진주모 20g
- 귀비탕습안신정지환: 인삼 10g, 백출 9g, 황기 9g, 감초 6g, 원지 9g, 조인 20g, 복신 15g, 원육 10g, 지모 12g, 용치 20g
- 이침: 神門, 心, 脾, 腎, 腦, 下端腳
- 체침: 내관, 노궁, 신문, 삼음교

② 우울

- 逍遙散和半夏厚樸湯化裁: 시호 15g, 당귀 12g, 백작약 12g, 백출 12g, 자감초 6g, 法半夏 12g, 후박 12g, 복령 15g, 생강 6g, 자소엽 6g
- 黃連阿膠湯合交泰丸: 황련 6g, 아교 10g, 황금 10g, 백작약 12g, 계자황(沖服) 2매, 육계 6g, 황백 9g, 진피 10g, 백출 10g, 백합 12g, 백자인 12g
- 이침: 神門, 枕, 心, 胃, 腦
- 체침: 인중, 내관, 신문, 풍릉, 용천

3단계: 폐기능 활성화 치료

① 금연치료 초기

- 기능 상승보다 금단증상 억제에 중점을 둔 한약제제 투여

② 금연치료 후기

- 폐기능 상승 한약제제와 금단증상 억제 한약제제 병행 투여
- 체침: 대저, 풍문, 폐수, 풍릉, 척택
- 이침: 對珠尖, 副腎, 咽喉, 後頭, 肺, 內鼻

	원인	증상	처방
鬱痰	화담이 심폐간에 울해서 생긴 것	가래를 뱉기 어려움, 인건, 구조, 해수, 천측	이진탕
痰濕咳嗽	담음이 상부의 폐에 저축되어 기기를 웅색하므로 해수가 발생	해수담다, 담백 혹은 위남부진	평위산
肺脹證	폐의 수강기능 장애	천해흉만	소청룡탕
支飲	폐, 비, 신, 삼초의 기능실조	이 차고 눕지 못하고 기대어 숨 쉬고 호흡이 짧음	소청룡탕
氣鬱證	액이 불행하여 청탁상간하여 기로부터 적이 만들어지고, 다시 적에서 담이 만들어져 기울함	흑비 흑통	이진탕
少氣證	기부족, 폐허, 신허	숨이 가늘고 기운이 적음	생맥산 보중익기탕
氣逆證	간에서 나온 상승지기에 상화를 결함	몸을 숙이거나 젖힐 때 숨이 차서 손으로 가슴 안고 숨을 내쉬	자음강화탕

신문혈과 중뇌피질변연계 보상회로

- 알코올은 시상하부 궁상핵에 있는 베타-엔돌핀 뉴런을 활성화. 이때 GABA는 활성억제
- 음주 → 엔돌핀 수치 상승 → GABA활성 억제 → 도파민 뉴런 활성 증가 → 보상회로, 기분이 좋아짐
- 반복적 노출시 보상회로가 하향조절. 술을 마시지 않으면 도파민 뉴런 활성 뚝 떨어짐.
- 쥐의 신문혈 자침 → 궁상핵의 베타 엔돌핀 뉴런을 활성화시켜 알코올 의존성을 낮추고, 보상회로를 정상화. 술에 대한 갈망이 줄어듦.